

Monotropismus messen: Trägheit, „Reibung“ und kognitive Energie – was die Evidenz tatsächlich stützt

Ein zitiertes Forschungsdossier – es überprüft das Framing „Monotropismus in Stufen einteilen“.

Information, kein medizinischer Rat. Dieses Dossier bewertet, wie Monotropismus gemessen werden kann und wie nicht. Der Monotropism Questionnaire (MQ) ist ein Selbstbeurteilungsinstrument der Forschung, **kein diagnostisches oder klinisches Werkzeug**, und er besitzt keine validierten Schweregrade.

Zusammenfassung

- **Ihr Instinkt ist bei der Kernidee richtig und bei der Verpackung falsch.** Die Vorstellung, dass Monotropismus auf einem Spektrum gemessen werden kann und dass die eigentlich interessierende Größe die **Anstrengung (die „Reibung“) beim Wechseln von Aufmerksamkeitszuständen** ist, ist gut belegt – aber die spezifische Vier-Stufen-Taxonomie („Niedrig / Mittel / Hoch / Extrem-Absolut“) ist ein populäres Framing, **keine validierte wissenschaftliche Klassifikation**.
- **Monotropismus ist zutreffend ein dimensionales Merkmal, kein Syndrom.** Das einzige validierte Instrument – der **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 – liefert eine kontinuierliche Punktzahl von 1 bis 5. Er hat **keinen veröffentlichten Schwellenwert, keine Perzentilbänder und keine Schweregrade** [2]. Ihn in benannte Stufen einzuteilen, ist immer eine willkürliche redaktionelle Entscheidung.

- **Die „Reibung“ des Wechselns hat bereits einen Namen: *autistische Trägheit*.** Dies ist ein reales, zunehmend erforschtes Konstrukt – eine Schwierigkeit beim *Beginnen, Stoppen und Wechseln* von Tätigkeiten, die „nicht der bewussten Kontrolle unterliegt“. Es wurde zuerst in autistischen Community-Erzählungen formuliert und ist nun in begutachteter Literatur [3][4][5]. Ihre „Wechsel-Reibung“ ist im Wesentlichen genau das.
- **„Aufmerksamkeitsträgheit“ vereint zwei unterschiedliche Dinge.** *Autistische Trägheit* (aufgabenbezogen: schwer zu beginnen/stoppen/wechseln) und *klebrige Aufmerksamkeit / gestörte Ablösung* (reizbezogen: schwer, die Aufmerksamkeit von etwas zu lösen, z. B. Landry & Bryson 2004; Sacrey 2015 Metaanalyse) sind verwandt, werden aber unterschiedlich gemessen [6][7]. Sie unter einem Begriff zusammenzufassen, kostet Präzision.
- **„Kognitive Energieökonomie“ ist das stärkste einzelne Framing** – und existiert akademisch bereits als Goldknopfs Modell der **„atypischen Ressourcenverteilung“** (2013), das Autismus als Unterschied darin fasst, *wie viel* Aufmerksamkeitsressourcen *wo* aufgewendet werden [10]. Das ist die neuroaffirmierende, nicht-defizitäre Version dessen, was Sie beschreiben.
- **Die Verbindung zu Burnout/Shutdown/Meltdown ist real, aber heuristisch.** Autistisches Burnout (Erschöpfung, Verlust von Fähigkeiten, verminderte Toleranz) ist ein etabliertes Konstrukt, und die *narrative* Verbindung zu erzwungenem Wechseln + Masking ist überzeugend und von der Community validiert – aber der spezifische Pfad „Monotropismus → Tunnelriss → Burnout“ ist weitgehend theoretisch und aus der Ich-Perspektive, noch nicht experimentell belegt [8][9].

1. Kann Monotropismus „gemessen“ werden? Ja – als Kontinuum, nicht als Stufen

Monotropismus ist eine aufmerksambasierte Erklärung von Autismus: Ein monotroter Geist leitet Verarbeitungsressourcen in eine kleine Zahl intensiv erregter „Aufmerksamkeitstunnel“ statt sie über viele Kanäle zu verteilen [1]. Weil er als *Unterschied in der*

Ressourcenverteilung beschrieben wird, ist er naturgemäß ein **Spektrum**, keine Kategorie – weshalb Ihre „Stufen“-Intuition sich richtig anfühlt.

Das validierte Instrument ist der **Monotropism Questionnaire (MQ)** – 47 Items, bewertet auf einer 5-stufigen Likert-Skala, 2023 von Garau und Kolleginnen und Kollegen *in Zusammenarbeit mit einer autistisch geführten Community-Gruppe* entwickelt [2]. Zwei Punkte sind für Ihre Frage entscheidend:

- **Er liefert einen einzigen kontinuierlichen Mittelwert (1–5) sowie acht Subskalen-Mittelwerte.** In der Validierungsstudie (1.110 Teilnehmende) erreichten autistische Teilnehmende im Mittel **4,15** und nicht-autistische **3,19**, wobei ADHD die Werte unabhängig anhub [2]. Die beiden Verteilungen überschneiden sich stark – viele nicht-autistische Menschen erzielen höhere Werte als einige autistische und umgekehrt.
- **Es gibt keinen Schwellenwert, keine Diagnostikgrenze, kein Schweregradband.** Ein Blick in die Validierungsarbeit bestätigt: Das Wort „cutoff“ erscheint nur als *statistischer* Verweis (Hu & Bentlers Kriterien für Fit-Indizes) und „sensitivity“ nur als *Sensitivitätsanalyse* dessen, wie Autismus definiert wurde [2]. Die Autorinnen und Autoren des MQ selbst schlagen keine Stufen vor.

Was also „bedeutet“ ein Wert? Nur seine relative Position auf der Dimension. Die Community-erstellte Online-App, die diese Frage anregte, übersetzt einen Wert hilfsweise in ein *Perzentil* („monotroener als etwa X % der autistischen / allistischen Menschen“), berechnet aus der Validierungsstichprobe – und das ist eine vernünftige, ehrliche Art, einen Wert einzuordnen. Aber es ist **ein deskriptives Perzentil, keine klinische Stufe**: „das 97. Perzentil der monotropen Neigung“ ist aussagekräftig; „Stufe 3 / Extremer Monotropismus“ ist ein Etikett, das die Evidenz nicht vergibt.

Fazit: Messen Sie ihn, tragen Sie ihn auf, perzentilieren Sie ihn – aber stufen Sie ihn nicht ein. Das Kontinuum ist real; die benannten Kategorien sind es nicht.

2. Ihre „Reibung des Wechsels“ existiert bereits: Sie heißt *autistische Trägheit*

Das ist die wichtigste Korrektur-nach-Name in diesem Dossier. Das Phänomen, das Sie beschreiben – die kognitive Kosten, *in* einen Aufmerksamkeitstunnel hinein- und vor allem wieder *hinaus*zugelangen – ist ein etabliertes Konstrukt namens **autistische Trägheit**: eine Schwierigkeit beim **Beginnen, Stoppen und Wechseln von Tätigkeiten, die nicht der bewussten Kontrolle unterliegt** [3].

Drei Punkte machen es direkt relevant:

- **Es stammt aus der autistischen Community und hat die begutachtete Literatur erreicht.** Die Association for Psychological Science beschreibt autistische Trägheit als „ein Konzept, das zuerst in autistischen Community-Erzählungen formuliert wurde“ und nun durch qualitative und theoretische Arbeit gestützt wird [4]. Karen Buckles Studie aus eigenem Erleben fand, dass Teilnehmende wiederholt beschrieben, Tätigkeiten nicht nach Belieben beginnen, stoppen oder wechseln zu können [3].
- **Die Literatur verwendet buchstäblich Ihre „Reibungs“-Sprache.** Der APS-Beitrag nennt die Aufgabeninitiierung einen „hoch-reibungsbehafteten Start“, fasst Wechseln als mit „Wechselkosten“ verbunden und stellt fest, dass einmal vertieft „der Wechsel des Fokus mehr kognitive Anstrengung erfordert, manchmal bis zur Erschöpfung“ [4]. Ihr Instinkt, *Aufwand/Reibung* zu quantifizieren, ist derselbe Schritt, den Forschende gehen.
- **Es wird inzwischen formalisiert.** Neuere begutachtete Arbeit fasst den „feststeckenden Zustand“ / die begrenzte Reaktionsinitiierung als ein Mehrebenen-Phänomen (muskulär-verhaltensbezogen „mikro“, relational und umweltbezogen „meso/makro“) und erarbeitet *mit* autistischen Menschen Unterstützungsrahmen [5]; andere modellieren es über Predictive-Processing-/Active-Inference-Ansätze (zitiert in [4]).

Kurz: Wer „Wechsel-Reibung“ messen will, misst autistische Trägheit – und dieses Konstrukt hat bereits qualitative Evidenz, Validität aus gelebter Erfahrung und eine wachsende quantitative Literatur, auf der sich aufbauen lässt.

3. „Aufmerksamkeitsträgheit“ bündelt tatsächlich zwei verschiedene Mechanismen

Hier zählt Präzision, denn die beiden Mechanismen verlangen unterschiedliche Sprache und (irgendwann) unterschiedliche Messinstrumente.

3.1 Autistische Trägheit – aufgabenbezogen, geht um Handlungsfähigkeit und Schwung. Schwierigkeit beim *Beginnen*, *Beenden* und *Wechseln* von Tätigkeiten, erlebt als unverhältnismäßiger Aufwand und ein Verlust der willentlichen Kontrolle (das Gefühl „ein Objekt in Bewegung bleibt in Bewegung / in Ruhe bleibt in Ruhe“) [3][4]. Das ist die nächste Passung zu Ihrer Idee, sich „aus dem Tunnel herauszuziehen“.

3.2 Klebrige Aufmerksamkeit / gestörte Ablösung – reizbezogen, geht um Wahrnehmung. Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit von einem Reiz *zu lösen*, einmal fixiert. Landry & Bryson (2004) zeigten, dass junge autistische Kinder deutlich langsamer waren, sich von einem zentralen Reiz zu lösen, wenn ein peripherer erschien – „klebrige Aufmerksamkeit“ [6]. Eine Metaanalyse von 2015 bestätigte die verlangsamte Aufmerksamkeits-Ablösung über Studien hinweg [7], und dieselbe träge Ablösung findet sich bei Säuglingen, die später als autistisch diagnostiziert werden [6]. Dies wird mit experimentellen Aufgaben (Gap/Overlap-Paradigmen) gemessen, nicht mit Fragebögen.

Warum die Unterscheidung zählt: Klebrige Aufmerksamkeit ist ein *perzeptueller* Erfassungseffekt (Sie bemerken die Unterbrechung buchstäblich nicht); autistische Trägheit ist ein *Kontroll-/Schwung*-Effekt (Sie bemerken es, können aber nicht wechseln). Ihre Vier-Stufen-Beschreibungen gleiten tatsächlich zwischen beiden – z. B. „Hintergrundreize werden vom Gehirn tatsächlich nicht verarbeitet“ ist klebrige Aufmerksamkeit [6], während „erzwungene Übergänge sich anfühlen, als ziehe man einen Zug von den Schienen“ Trägheit ist [3]. Ein sorgfältiges Modell sollte beide getrennt etikettieren, weil sie unterschiedliche Ursachen und unterschiedliche Unterstützung haben können.

4. Die vier vorgeschlagenen „Stufen“ – was gestützt ist, was erfunden

Anstatt die Taxonomie rundherum zu billigen oder zu verwerfen, wird hier jede vorgeschlagene Stufe gegen die Evidenz geprüft.

Vorgeschlagene Stufe	Kernbehauptung	Evidenzurteil
Niedrig (polytrop-dominant)	Viele „Tabs“ offen; Wechselkosten nahe null	Als eines Ende des Kontinuums gestützt. Die niedrigeren Scorer des MQ und der nicht-autistische Gruppenmittelwert (3,19) beschreiben genau das [2]. „Polytrop“ ist der eigene Begriff der Theorie dafür [1].
Mittel	Kann tief fokussieren, behält aber Basisbewusstsein; leichte Wechselkosten	Als Mitte der Dimension gestützt. Flow-Zustände werden über die Bevölkerung berichtet; die MQ-Werte zwischen den Gruppenmitteln erfassen dieses Band [2][11]. Aber der <i>Name</i> ist willkürlich.
Hoch	Bevorzugt einen einzelnen, intensiven Tunnel; Unterbrechungen tatsächlich verpasst; hohe Wechselkosten	Mechanismus gestützt, Kategorie nicht. Die Bestandteile sind real – verpasste Unterbrechungen = klebrige Aufmerksamkeit [6][7]; hohe Wechselkosten = autistische Trägheit [3] [4]; starke Autismus-/ADHD-Assoziation = MQ-Befunde [2]. Aber es gibt keine Schwelle, die „Hoch“ von „Mittel“ trennt.
Extrem / Absolut	Völliges Versenken; Störung verursacht „neurologischen Schock“, Meltdowns, Shutdowns	Überzogen. Tiefes Versenken („Flow“) und Belastung bei Störung sind real [11], aber „absolut“ impliziert einen qualitativen Sprung, den die Daten nicht zeigen , und „neurologischer Schock“ ist kein anerkannter Begriff. Meltdowns/Shutdowns sind unwillkürliche Überlastungsreaktionen, kein für ein Monotropismus-Band spezifischer „Schock“.

Drei Probleme, die Taxonomie so zu veröffentlichen:

1. **Sie impliziert kategoriale Sprünge, wo die Daten ein glattes Kontinuum zeigen.** Die MQ-Verteilungen autistischer und nicht-autistischer Menschen überschneiden sich beträchtlich [2]; es gibt keinen natürlichen „Knick“, der vier diskrete Stufen rechtfertigen würde.
2. **Sie schmuggelt Schwere/Pathologie ein.** „Extrem/absolut ... Meltdowns, Burnout“ rahmt das obere Ende als inhärent schädlich – das Gegenteil des neuroaffirmierenden Framings, das die Theorie beabsichtigt [1]. Höherer Monotropismus ist *nicht* dasselbe wie schlechtere Ergebnisse; Ergebnisse hängen vom *Umwelt-Pass* ab, nicht von der Stufe.
3. **Die Bänder haben keine Reliabilitätsdaten.** Ein nützliches Stufensystem muss zeigen, dass Menschen beim Wiederholen im selben Band landen und dass Bänder etwas vorhersagen. Eine solche Studie existiert für Monotropismus nicht.

Was stattdessen tun. Drücken Sie dieselbe Idee als *Position auf der Dimension* plus ein *Profil* aus: „Hohe monotrope Neigung ($\approx$ obere X % der autistischen Stichprobe), mit ausgeprägter autistischer Trägheit beim Aufgabenwechseln und häufigen störungsbedingten Meltdowns in wenig unterstützenden Umwelten.“ Das ist präzise, individualisiert und nicht-pathologisierend.

5. Störung → Meltdown, Shutdown, Burnout: was die Evidenz stützt

Dieser Teil Ihres Framings ist der folgenreichste und bedarf der größten Sorgfalt.

Meltdowns und Shutdowns sind real und gut beschrieben als unwillkürliche Reaktionen auf überwältigenden Stress oder sensorische/kognitive Last (ein externalisierender „Meltdown“ vs. ein internalisierender, sich zurückziehender „Shutdown“) – anerkannt in klinischen Leitlinien und im Community-Konsens. Sie werden durch *Überlastung* ausgelöst, wobei ein Tunnelriss ein häufiger Weg dorthin ist [4][8].

Autistisches Burnout ist inzwischen ein definiertes Konstrukt. Zwei grundlegende Studien – Raymaker et al. (2020) und Higgins et al. (2021, eine Grounded-Delphi-Studie mit autistischen Expertinnen und Experten

aus eigenem Erleben) – konvergieren auf einer Definition: **chronische Erschöpfung, Verlust von Fähigkeiten und verminderte Reiztoleranz**, verstanden als Folge chronischen Lebensstresses und „einer Diskrepanz zwischen Erwartungen und Fähigkeiten“ ohne angemessene Unterstützung und Erholung [8][9].

Die Verbindung Monotropismus → Burnout ist heuristisch mächtig, aber noch nicht experimentell belegt. Die Erzählung ist überzeugend und von der Community validiert: Jeder erzwungene Übergang ist ein Tunnelriss; ständiges Masking und Wechseln in einer polytropen Welt verbrennt Ressourcen; ohne Erholungs-/Flow-Zeit erschöpft sich das System [8][9][11]. Aber der *spezifische* Beitrag des monotropen Tunnelrisses zum Burnout – gegenüber Masking, Trauma, sensorischer Last und chronischer Anforderung – wurde experimentell nicht isoliert. Formulieren Sie es als *starke, testbare Hypothese*, nicht als etablierte Tatsache.

Die ehrliche, evidenzbasierte Aussage lautet: „Autistisches Burnout wird durch chronischen Stress, Masking und eine Diskrepanz zwischen Anforderungen und Kapazität angetrieben; der Monotropismus-Rahmen sagt voraus, dass ständiges erzwungenes Wechseln und Tunnelrisse ein wesentlicher, zu wenig anerkannter Mitverursacher sind – eine Vorhersage, die zum gelebten Erleben passt und der direkten Prüfung noch harrt.“

6. „Kognitive Energieökonomie“ – Ihr stärkstes Framing

Ihr Schlussschritt – der Wechsel von „Defizit“ zu „wie viel Kraft ein Gehirn beim Hochschalten verbraucht“ – ist genau richtig, und er hat bereits ein akademisches Zuhause.

Goldknopfs Modell der „**atypischen Ressourcenverteilung**“ (2013) operationalisiert Monotropismus als Unterschied in der *Ressourcenökonomie*: Aufmerksamkeitsressourcen bei Autismus sind **verschmälert** (auf weniger/kleinere Kanäle konzentriert, teils intensiver) und/oder **in der Gesamtkapazität vermindert** [10]. Auf dieser Sicht ist die „Kosten“ eines Übergangs buchstäblich der energetische Aufwand, ein Verteilungsmuster aufzulösen und ein neues aufzubauen. Das ist „kognitive Energieökonomie“, präzise formuliert –

und es ist das Framing, das mit einem nicht-pathologisierendem Ansatz am besten vereinbar ist, weil es das Problem als *Ausgaben* (ein Unterschied im Haushalten) fasst statt als *Defekt*.

Das ist das Framing, das Sie behalten sollten. Drei Vorteile:

- Es ist **wertneutral**: Intensiver Fokus ist ein Gewinn, wenn die Umwelt ihn trägt (Flow, Expertise), und ein Kostenpunkt, wenn die Umwelt ständiges Wechseln verlangt [10][11].
- Es **sagt Interventionen voraus**: unnötige Übergänge reduzieren, Flow-/Erholungszeiten schützen, Anforderungen an die Kapazität anpassen – und die „Kraftrechnung“ sinkt; genau das empfiehlt die Leitlinie zur Burnout-Prävention [8][9].
- Es **vereint** die Phänomene Ihrer vier Stufen, ohne die Stufen zu brauchen: verpasste Reize, Wechselkosten, Überlastung und Burnout werden allesamt Folgen *der Art, wie Ressourcen verteilt und erschöpft werden*, auf einem Kontinuum.

7. Praktische Erkenntnisse – was behaupten, was vermeiden

Zuversichtlich behaupten:

- Monotropismus ist ein messbares, **dimensionales** Merkmal (MQ, 1–5, mit acht Subskalen); geben Sie den Wert und optional das Perzentil an, nicht eine „Stufe“ [2].
- Die von Ihnen beschriebene „**Wechsel-Reibung**“ ist **autistische Trägheit** – ein reales, aus der Community stammendes, inzwischen begutachtetes Konstrukt [3][4][5].
- **Klebrige Aufmerksamkeit** / **gestörte Ablösung** ist ein eigenständiger, experimentell gemessener Mechanismus [6][7].
- **Autistisches Burnout** ist ein definiertes Konstrukt, angetrieben durch chronischen Stress, Masking und eine Anforderungs-Kapazitäts-Diskrepanz; monotoper Tunnelriss ist ein *plausibler, über gelebtes Erleben validierter* Mitverursacher [8][9].
- „Kognitive Energieökonomie“ $\approx$ Goldknopfs Modell der **Ressourcenverteilung** – das präziseste, neuroaffirmierendste Framing [10].

Vermeiden oder umbenennen:

- Benannte **Stufen / Bänder** („Niedrig/Mittel/Hoch/Extrem“) – nicht validiert; verwenden Sie stattdessen Position-auf-der-Dimension + Profil.
- „**Aufmerksamkeitsträgheit**“ als Sammelbegriff – sie verwischt autistische Trägheit (Aufgabe/Kontrolle) mit klebriger Aufmerksamkeit (Wahrnehmung); verwenden Sie den präzisen Begriff [3][6].
- „**Absoluter**“ Monotropismus und „**neurologischer Schock**“ – keine anerkannten Begriffe; sie implizieren einen kategorialen Sprung und eine Pathologie, die die Daten nicht stützen.
- Den Pfad **Monotropismus** → **Burnout** als etabliert darzustellen – es ist eine starke Hypothese, keine gemessene Wirkung [8].
- Jedes Framing, in dem **höher** = **gestörter** – die Ergebnisse von Monotropismus hängen vom Umwelt-Pass ab, nicht von der Stufe [1] [10].

Quellen

- [1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.
doi:10.1177/1362361305051398 — Ursprung der Monotropismustheorie; fasst sie als Unterschied in der Ressourcenverteilung (ein Kontinuum), nicht als Defizit. <https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- [2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (47-Item-Selbstbeurteilungsinstrument; Validierungs-Preprint). Open Science Framework. — dimensionaler 1–5-Wert + 8 Subskalen; n=1.110; autistischer Mittelwert 4,15 vs. nicht-autistisch 3,19; ADHD hebt die Werte; **kein Schwellenwert/Perzentilband/Schweregrad** (durch Sichten des Validierungs-Manuskripts bestätigt). Fragebogen: <https://osf.io/wpx5g> · Validierungs-Preprint: <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Lokales Archiv: [sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf](#)
- [3] Buckle, K. et al. (2021). *"No way out except from external intervention": First-hand accounts of autistic inertia*. (Preprint / qualitativ).
doi:10.31234/osf.io/ahk6x — autistische Menschen beschreiben die Schwierigkeit, Tätigkeiten zu beginnen, zu stoppen und zu wechseln, „die

nicht ihrer bewussten Kontrolle unterlag“. Lokales Archiv: [sources/11-autistic-inertia-osf.pdf](#) · <https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x> ·

Manchester Research Explorer:

<https://research.manchester.ac.uk/en/publications/no-way-out-except-from-external-intervention-first-hand-accounts->

[4] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer, Association for Psychological Science. — fasst autistische Trägheit als „zuerst in autistischen Community-Erzählungen formuliert“, inzwischen begutachtet; verwendet die Sprache „hochreibungsbefallener Start“ und „Wechselkosten“; zitiert Carls-Diamante & Laciny (2024), Greaves-Lord et al. (2023), Buckle et al. (2021), Heasman et al. (2024), Rapaport et al. (2024), Phung et al. (2021).

<https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>

[5] Greaves-Lord, L. et al. (2023). *[Getting 'stuck': an integrative approach to support autistic people]* Frontiers in Psychology, doi:10.3389/fpsyg.2023.1229596. — begutachteter qualitativer + Delphi-Rahmen zur begrenzten Reaktionsinitiierung („feststeckender Zustand“) bei autistischen Menschen über Mikro-/Meso-/Makro-Ebenen, mit autistischen Menschen mitarbeitet.

<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1229596>

[6] Landry, R. & Bryson, S. (2004). *Impaired disengagement of attention in young children with autism*. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(6), 1115–1122. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x — „klebrige Aufmerksamkeit“: verlangsamte Ablösung von einem Reiz.

<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x>

[7] Sacrey, L.-A. et al. (2015). *Attention disengagement in autism spectrum disorder: A meta-analysis*. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 56, 111–121. doi:10.1016/j.neubiorev.2014.10.011 — bestätigt die verlangsamte Aufmerksamkeits-Ablösung über Studien hinweg.

<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011>

[8] Raymaker, D. M. et al. (2020). *"Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout*. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143.

doi:10.1089/aut.2019.0079 — definiert autistisches Burnout als chronische Erschöpfung, Verlust von Fähigkeiten, verminderte Reiztoleranz, aus chronischem Lebensstress und einer Diskrepanz

zwischen Erwartungen und Fähigkeiten.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> · Open
Archive: https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378

[9] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating #AutisticBurnout*. Autism, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 — Konsensdefinition: Erschöpfung, Rückzug, Probleme im Denken, verminderte Alltagskompetenzen, Zunahme autistischer Züge.

<https://www.autismcrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic>

[10] Goldknopf, E. J. (2013). *Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism*. Frontiers in Integrative Neuroscience.

PMC3872719 — modelliert Autismus als Unterschied in der Ressourcenverteilung (vershmälerte und/oder verminderte Aufmerksamkeitsressourcen); die akademische Form der „kognitiven Energieökonomie“. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719>

[11] Rapaport, H., Clapham, H., Adams, J., Lawson, W., Porayska-Pomsta, K., & Pellicano, E. (2024). *"In a State of Flow": experiential validity of monotropism and its relation to autistic wellbeing*. Autism in Adulthood. doi:10.1089/aut.2023.0032 — der positive Pol tiefen monotropen Versenkens (Flow); stützt das Framing „ein Gewinn, wenn unterstützt“.

Lokales Archiv: [sources/18-flow-experiential-validity-pmc.html](#) · <https://doi.org/10.1089/aut.2023.0032>